

精神作用物質関連障害

脳の病気としての理解と包括的アプローチ

名古屋市立大学大学院医学研究科

精神・認知・行動医学分野

大山 覚照

物質関連症及び嗜癖症群

- DSM-5-TRでは、物質関連症群は10群の薬物を含めている(アルコール、カフェイン、大麻、幻覚薬、吸入剤、オピオイド、鎮静薬、睡眠薬又は抗不安薬、精神刺激薬、タバコ、他の《または不明の》物質)

* DSM-5: アメリカ精神医学会が作成した精神疾患の診断基準および分類をまとめたマニュアル

- 物質関連症群 — 物質使用症群 (物質依存症)
— 物質誘発症群 (物質中毒、物質離脱、他の物質・医薬品誘発性精神疾患*)

* 他の物質・医薬品誘発性の精神症、双極症及び関連症、抑うつ症、不安症、強迫症及び関連症、睡眠障害、性機能不全、せん妄、神経認知障害

- 非物質関連症群 — ギャンブル行動症

精神作用物質の分類

精神作用物質とは

⇒中枢神経に作用して認知や気分に影響を与える物質の総称

- 中枢神経抑制薬（アルコール、ベンゾジアゼピン、オピオイド）
- 中枢神経興奮薬（覚醒剤、コカイン、ニコチン）
- 幻覚薬（LSD、大麻、MDMA）

薬理作用による分類

(1) 中枢神経抑制薬

- 中枢神経の活動を抑制する作用

- 主な中枢神経抑制薬

アルコール、ベンゾジアゼピン受容体作動薬、バルビツール酸類、オピオイド など

- 低濃度 大脳皮質の活動を軽く抑制⇒不安・緊張・警戒心を緩和

↓ 血中濃度上昇すると理性による抑制が低下⇒攻撃性・衝動性が促進

↓ 大脳辺縁系が抑制⇒覚醒水準低下、傾眠状態

↓ 小脳抑制⇒運動失調、姿勢保持困難

- 高濃度 脳幹抑制⇒自発呼吸抑制など生命維持機能に障害

薬理作用による分類

(2) 中枢神経興奮薬(精神刺激薬)

- 中枢神経の神経活動を促進する作用
- 主な中枢神経興奮薬(精神刺激薬)

覚醒剤(アンフェタミン、メタンフェタミン)、メチルフェニデート、コカイン、カフェイン

- 気分高揚、意欲増進、集中力・注意力の高まり⇒精神活動が促進
- 交感神経系の働き亢進⇒食欲低下、不眠、血圧上昇、頻脈
- 不安・警戒心の高まり⇒攻撃的になる

⇒被害念慮・幻聴・妄想などの精神症症状出現

薬理作用による分類

(3) 幻覚薬

- 五感の知覚を変容・歪曲させ、錯視、錯聴、視覚優位の幻覚体験を生じる
- 主な幻覚薬

LSD、MDMA、シロシビン(マジックマッシュルーム＝幻覚誘発性キノコの主成分)、PCP

身体依存と精神依存

- 耐性:

- ・当初と同じ水準の薬理作用を得るのに必要な量が増える現象
- ・中枢神経系の恒常性維持のための馴化・適応作用

- 離脱:

- ・一定水準以上の耐性が形成された状態で、急激に薬物投与を中断した際に生じる中枢神経系の反跳性の過剰興奮
- ・典型的な離脱は、自律神経系の興奮を伴う激しい症状
- ・主観的な苦痛を伴い、新たな恒常性獲得までの数日間生じる
- ・離脱の苦痛から逃れようと、薬物探索行動を引き起こす

* 激しい自律神経症状(狭義の離脱)が顕著に出るのは、アルコールや睡眠薬などの中枢神経抑制薬の特徴

* 中枢神経興奮薬は苦痛や自律神経症状を伴う狭義の離脱は生じない

* 幻覚薬の多くも狭義の離脱はほとんど生じず、耐性形成も比較的弱い

身体依存と精神依存

●身体依存

- ・ 中枢神経作用薬を繰り返し投与されることで高度な耐性を生じ、薬物投与中断時に自律神経系の反跳を伴う離脱を生じるようになった状態
- ・ 身体依存が存在すると、物質を手放しにくくなる重要な要因となる

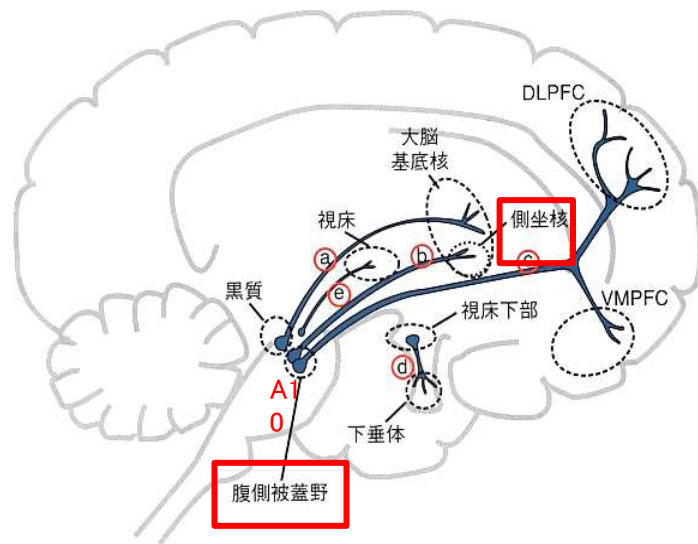
●精神依存

- ・ 物質がもたらす快感に魅せられ、物質を使用していない状態で生じる「○○が欲しい」といった飢餓感を「渴望」と呼ぶ
- ・ 渴望に駆られ、仕事・勉強・家庭内の役割を犠牲にして物質使用を優先してしまい、物質使用をやめることができなくなった状態を「コントロール障害」という
- ・ 「渴望」と「コントロール障害」を生じた状態を精神依存と呼ぶ

精神依存の生物学的機序(報酬系)

●報酬系

- 中脳腹側被蓋野から投射する**ドパミン作動性神経系(A10神経系)**が、側坐核や前頭前野に軸索を延ばし、報酬系と呼ばれる**神経回路**を形成する
- 精神作用物質はその薬理作用の如何にかかわらず、様々な神経回路を経て**最終的には、A10神経系を興奮させ、快感を生じさせる**
- **中枢神経興奮薬**が**身体依存を形成せず**に強力な**精神依存を形成**するのは、他の神経回路を介さず、直接A10神経終末のドパミン再取り込み部位に作用し興奮を引き起こすから



中枢作用	薬物のタイプ	精神依存	身体依存	耐性	催幻覚	精神毒性	法的分類
抑制	アヘン類（オピオイド）	+++	+++	+++	－	－	麻薬
抑制	バルビツール類	++	++	++	－	－	向精神薬
抑制	アルコール	++	++	++	－	+	その他
抑制	ベンゾジアゼピン	+	+	+	－	－	向精神薬
抑制	有機溶剤	+	±	+	+	++	毒物劇物
抑制	大麻	+	±	+	++	+	大麻
興奮	コカイン	+++	－	－	－	++	麻薬
興奮	覚せい剤	+++	－	+	－	+++	覚せい剤
興奮	LSD	+	－	+	+++	±	麻薬
興奮	ニコチン	++	±	++	－	－	その他

「誰にでもできる薬物依存症の診かた」 成瀬暢也著 中外医学社 より一部改変して引用

アルコール関連症群について

アルコール関連症群の位置づけ

DSM-5-TR

アルコール使用症（アルコール依存症）

アルコール中毒

アルコール離脱

アルコール誘発性精神疾患群

アルコール使用症の診断基準

DSM-5-TR

過去12か月のあいだに以下の11項目のうち2項目以上に当てはまる場合

- ①意図したより大量、もしくは長時間使用する
- ②止めよう、減らそうと試みるが成功しない
- ③物質を入手・使用する、あるいは物質の影響から回復するのに多くに時間を費やす
- ④渴望がみられる
- ⑤物質を繰り返し使用することで、職場・学校・家庭で責任を果たせない
- ⑥社会的問題、対人トラブルが生じているにもかかわらず物質の使用を続ける
- ⑦物質使用のために社会的、職業的、娯楽的活動を放棄したり、犠牲にしている
- ⑧身体的に危険な状況でも使用を繰り返す
- ⑨身体的、精神的問題が悪化しているとわかっているのに使用を続ける
- ⑩耐性ができている
- ⑪離脱症状がみられる

重症度の区分(DSM-5-TR)

軽症:2～3項目あてはまる 中等症:4～5項目あてはまる 重症:6項目以上あてはまる

使用障害 (Use Disorder)

乱用・有害な使用 (Abuse)

誤った使用方法により問題を引き起こしている状態

依存 (Dependence)

身体的・精神的依存が形成された疾患状態

アルコール使用症の現状

世界的傾向

15歳以上の世界人口の約7%(約4億人)がアルコール使用障害を抱えている
そのうち約2億900万人がアルコール依存症

肝疾患、がん、事故など多岐にわたる影響

しかし、治療や支援へのアクセスは依然として低く、治療を受けている人は1%~14%程度

アルコール関連死

世界では260万人以上がアルコール関連疾患で死亡

日本ではアルコール性肝疾患による死亡者数5,480人(男性4,782人女性698人)

アルコール寄与死亡数は、5万人を超え、全死亡数の4.0%を占めた

世界的に2010年から2019年にかけて、アルコール関連死は20.2%減少している

社会的コスト

医療費、労働損失、犯罪関連費用を含めると、日本では年間5兆円を超える社会的コストが発生

アルコール使用症

- アルコールが引き起こす諸問題

- ①健康被害

- ・ 早期死亡に関連する主要な19のリスク因子のうち、アルコールは8番目のリスク因子(WHO)
- ・ アルコールの寄与割合の高い疾患：肝硬変、外傷、がん、精神・神経障害

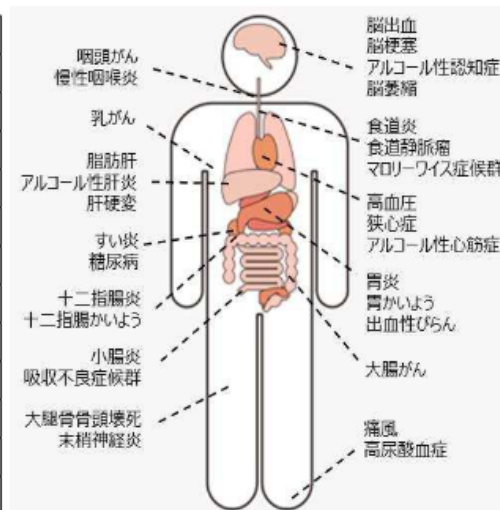
- ②社会的被害

- ・ 飲酒運転
- ・ 家庭内暴力と養育への影響
- ・ 自殺
 - ・ アルコール使用症はうつ病と並ぶ自殺リスクの高い精神疾患
 - ・ 酩酊による衝動性亢進
 - ・ 自殺者に特有の心理的視野狭窄を悪化させる

◆我が国における疾病別の発症リスクと飲酒量（純アルコール量）

これまで、1日あたりの純アルコール摂取量男性 20g 程度、女性・高齢者 10g 程度は、「節度ある適度な飲酒」とされてきました（第一次健康日本21）が、令和6年2月に厚生労働省が策定した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」において、少しの飲酒でもリスクが上がる疾病があることが示されました。

疾病名	飲酒量（純アルコール量（g））	
	男性	女性
脳卒中（出血性）	150g/週（20g/日）	少しでもリスクあり
脳卒中（脳梗塞）	300g/週（40g/日）	75g/週（11g/日）
高血圧	少しでもリスクあり	少しでもリスクあり
胃がん	少しでもリスクあり	150g/週（20g/日）
肺がん（喫煙者）	300g/週（40g/日）	データなし
肺がん（非喫煙者）	関連なし	データなし
大腸がん	150g/週（20g/日）	150g/週（20g/日）
食道がん	少しでもリスクあり	データなし
肝がん	450g/週（60g/日）	150g/週（20g/日）
前立腺がん（進行がん）	150g/週（20g/日）	データなし
乳がん	データなし	100g/週（14g/日）



注：上記の飲酒量の数値は、これ以上の飲酒をすると発症等のリスクが上がると思われるもの。「関連なし」は飲酒量（純アルコール量）とは関連が無いと考えられるもの。「データなし」は飲酒量（純アルコール量）と関連する研究データがないもの。

【出典】健康に配慮した飲酒に関するガイドライン（厚生労働省）

飲酒量の計算（純アルコール摂取量）

◆お酒に含まれるアルコール量の計算方法

お酒の量(ml)・アルコール度数(%)・アルコールの比重

$$\boxed{} \times (\boxed{} \div 100) \times 0.8$$

純アルコール換算で 10g = 1 ドリンクという単位が使われています。

2 ドリンク（純アルコール 20g）の例



清酒
1合
180 ml



ビール
ロング缶1本
500ml



ウイスキー
ダブル1杯
60ml



焼酎
0.6合
110ml



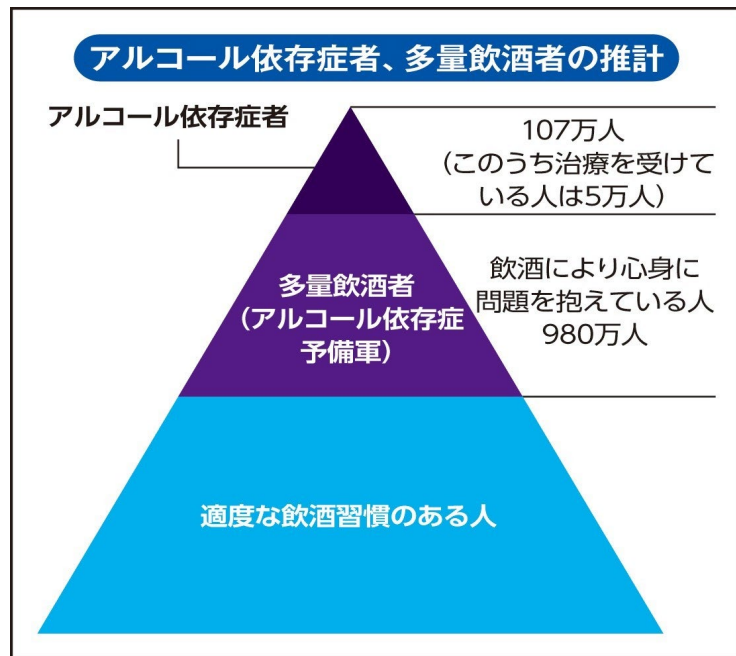
ワイン
グラス1.5杯
180ml



缶酎ハイ
1本(7%)
350 ml

※9%のストロング系チューハイは、ロング缶（500ml）1本だけで、ほぼ4ドリンク（日本酒換算で2合）に達します。

日本における治療ギャップ



わが国において生活習慣病のリスクを高める飲酒(1日平均男性40g 以上、女性20g 以上)をする人が約1000 万人

これまでにICD-10によるアルコール依存症の診断基準に該当したことのある人は107万人と推計

推定107万人の依存症患者のうち、実際に治療を受けているのは約5万人に過ぎない

アルコール性肝疾患での受診患者数37,000人 (2017年)

この大きな治療ギャップを埋めることが、精神科医療の重要な課題

(新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドライン.日本アルコール・アディクション医学会 日本アルコール関連問題学会. 2018, 時事メディカル2019, 人 厚生労働省患者調査. 2017年)

第 82 表 飲酒習慣の状況－飲酒習慣の状況，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29 歳		30－39 歳		40－49 歳		50－59 歳		60－69 歳		70 歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	5,473	100.0	402	100.0	607	100.0	753	100.0	1,034	100.0	1,004	100.0	1,673	100.0
	飲酒習慣あり	1,086	19.8	30	7.5	103	17.0	180	23.9	266	25.7	269	26.8	238	14.2
	飲酒習慣なし	4,387	80.2	372	92.5	504	83.0	573	76.1	768	74.3	735	73.2	1,435	85.8
男 性	総 数	2,578	100.0	209	100.0	298	100.0	347	100.0	480	100.0	481	100.0	763	100.0
	飲酒習慣あり	828	32.1	20	9.6	75	25.2	128	36.9	187	39.0	212	44.1	206	27.0
	飲酒習慣なし	1,750	67.9	189	90.4	223	74.8	219	63.1	293	61.0	269	55.9	557	73.0
女 性	総 数	2,895	100.0	193	100.0	309	100.0	406	100.0	554	100.0	523	100.0	910	100.0
	飲酒習慣あり	258	8.9	10	5.2	28	9.1	52	12.8	79	14.3	57	10.9	32	3.5
	飲酒習慣なし	2,637	91.1	183	94.8	281	90.9	354	87.2	475	85.7	466	89.1	878	96.5

注 1) 生活習慣調査票の問 13 (飲酒の頻度) で「1」～「5」と回答し，問 13－1 (1 日当たり飲酒量) に回答している者，(5 年)
及び問 13「6」～「8」に回答している者を集計対象とした。

注 2) 「飲酒習慣のある者」とは，週に 3 回以上飲酒し，飲酒日 1 日当たり 1 合以上を飲酒すると回答した者。

週に3回以上飲酒し，飲酒日1日当たり1合以上を飲酒する、飲酒習慣のある人は40代以上の男性では4割近くいる

(2023年国民健康・栄養調査報告)

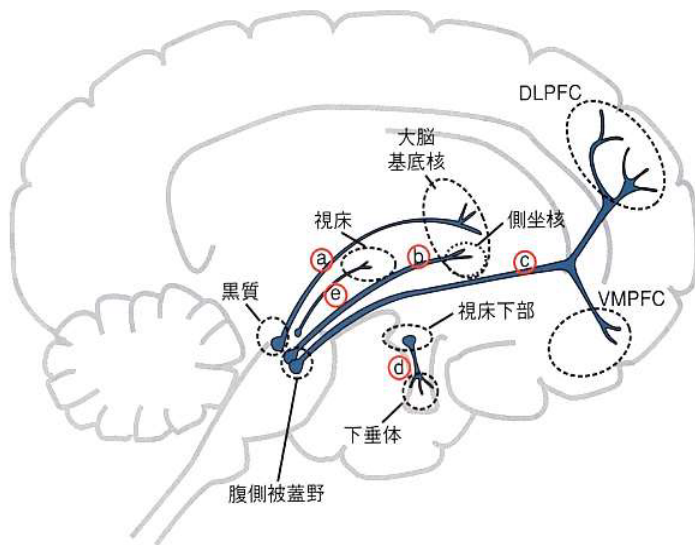
アルコールの神経作用

中枢神経抑制薬

中枢神経の活動を抑制する作用

- 低濃度 大脳皮質の活動を軽く抑制 ⇒ 不安・緊張・警戒心を緩和
 - ⇓ 血中濃度上昇すると理性による抑制が低下 ⇒ 攻撃性・衝動性が促進
 - ⇓ 大脳辺縁系が抑制 ⇒ 覚醒水準低下、傾眠状態
 - ⇓ 小脳抑制 ⇒ 運動失調、姿勢保持困難
- 高濃度 脳幹抑制 ⇒ 自発呼吸抑制など生命維持機能に障害

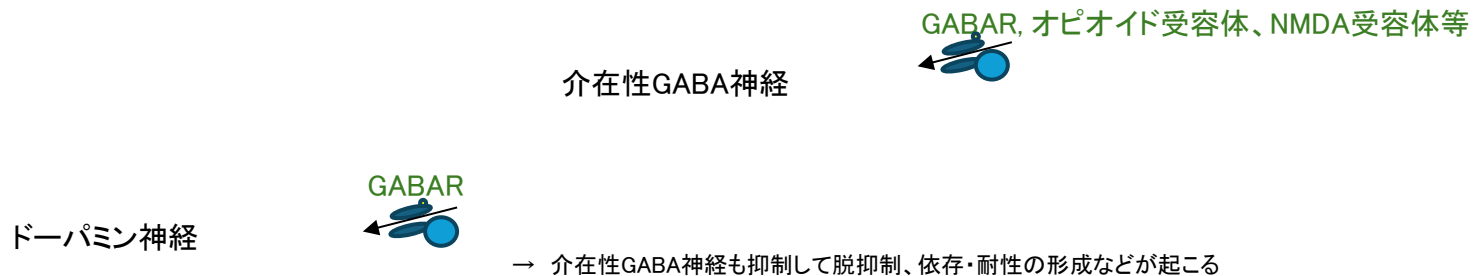
依存形成の神経機構



アルコール依存症は脳の報酬系の機能障害です。腹側被蓋野(VTA)から側坐核(NAc)、前頭前野(PFC)へと続く神経回路が中心的な役割を果たす。

飲酒を行うことで μ オピオイド(μ)受容体と σ オピオイド(σ)受容体が刺激され、ドパミンが放出、多幸福感を感じる。ドパミン神経系の活性化により、飲酒行動が強化され、やがて制御不能な渴望へと発展していきます。前頭前野の機能低下により、判断力や抑制機能が障害される。

中枢神経抑制薬によりドーパミン放出が増強するメカニズム



神経伝達物質の変化

- ・ 耐性：
 - ・ 当初と同じ水準の薬理作用を得るのに必要な量が増える現象
 - ・ 中枢神経系の恒常性維持のための馴化・適応作用

飲酒時

- ・ GABA作用 ↑ (抑制系亢進)
- ・ グルタミン酸 ↓ (興奮系抑制)
- ・ ドパミン放出 ↑ (報酬感)
- ・ セロトニン ↑ (気分改善)

断酒時

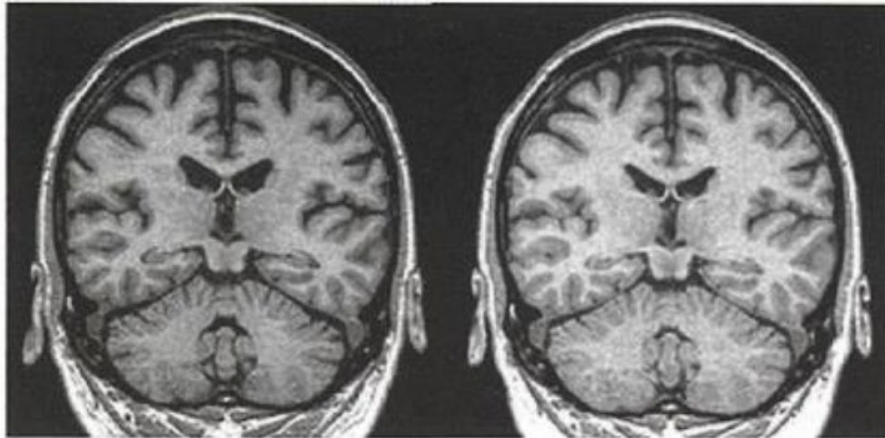
- ・ GABA作用 ↓ (抑制系低下)
- ・ グルタミン酸 ↑ (興奮系亢進)
- ・ ドパミン ↓ (不快感)
- ・ ノルアドレナリン ↑ (不安)

この神経伝達物質のアンバランスが、離脱症状や渴望の生物学的基盤となる。

依存形成による「脳の変化」

- 前頭前野の機能低下：ブレーキが効かない状態になる。
- 脳萎縮のMRI所見：長期使用による萎縮が見られる。
- 可塑性：断酒・断薬を継続することで回復の可能性がある。

【断酒により脳萎縮が改善した人のMRI画像】



Gazdzinski S, et al., Drug Alcohol Depend, 2005

〈断酒前〉

〈断酒後〉

脳画像所見

長期的なアルコール使用により、脳萎縮が認められる
断酒により回復が期待できる

- アルコール関連症

- ① アルコール中毒

- 単純酩酊 : アルコール血中濃度に伴って進行する酩酊
 - 異常酩酊
 - 複雑酩酊 : 飲酒によって気分が易刺激的となり、著しい興奮が出現する状態
(脱抑制的な行動が生来の性格や普段の行動パターンと質的に異なるレベル)
 - 病的酩酊 : 意識障害があり、単純酩酊や複雑酩酊とは質的に異なる状態

● アルコール関連症

②アルコール離脱

(1) 早期症候群

- ・ 飲酒停止直後から出現し、最終飲酒から24～36時間にピーク、48時間まで続く
- ・ 不安・焦燥・抑うつ、動悸・血圧上昇・発汗・悪心、手指・眼瞼・体幹の振戦、てんかん様の大発作
- ・ 意識清明下での一過性の要素性幻聴
- ・ 顕著な意識障害は呈さないが、軽度の見当識障害を伴うことがある

(2) 後期症候群(大離脱)

- ・ 飲酒停止後72～96時間に出現し、3～4日持続
- ・ 振戦せん妄(顕著な発汗、四肢の粗大な振戦、幻覚、意識変容)
- ・ 幻覚は視覚優位(小動物幻視)
- ・ 被暗示性の亢進(リープマン現象: 上眼瞼を圧迫して暗示を与えると幻視が生ずる)

- アルコール関連症

- ③アルコール誘発性精神疾患

- 嫉妬妄想
 - アルコール幻覚症
 - 振戦せん妄と異なり意識清明下で生じる
 - 要素性幻聴
 - 統合失調症と異なり思考障害や陰性症状を認めない

- ④アルコールに関連する器質性精神疾患

- Wernicke脳症
 - Korsakoff症候群

アルコール使用症の治療

治療の進め方

1) 急性期治療

- 解毒と離脱管理・栄養管理
 - ・ベンゾジアゼピン受容体作動薬（アルコールと交叉耐性を持つ）
 - ・隔離室を用いた解毒
 - ・ビタミン類の投与

2) リハビリテーション期治療

- 心理社会的治療
 - ・動機付け（動機づけ面接）
 - ・心理教育
 - ・認知行動療法（依存症再発防止トレーニング）
 - ・依存症デイケア
- 薬物療法
 - ・抗酒剤、断酒補助薬、飲酒量低減薬

アルコール使用障害の急性症状 急性アルコール中毒・離脱せん妄など

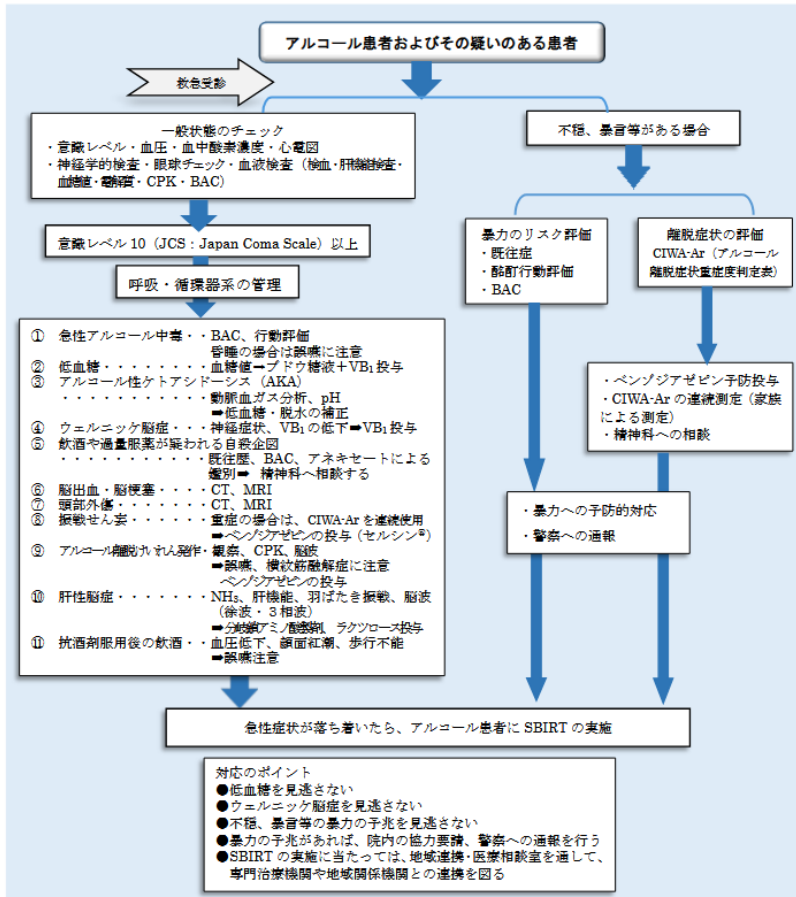


図1 アルコール救急診療フローチャート⁷⁾

血中アルコール濃度 (BAC) 検査

表 3 ステージ別の BAC・酩酊状態・飲酒量

ステージ	BAC	酩酊状態	飲酒量
爽快期	20～40 mg/dl	さわやかな気分になる 皮膚が赤くなる 陽気になる 判断力が少しにぶる	ビール中びん(500ml)1本以下 日本酒1合以下 ウイスキー・シングル2杯以下
ほろ酔い期	50～100 mg/dl	ほろ酔い気分になる 手の動きが活発になる 抑制がとれる(理性が失われる) 体温が上がる 脈が速くなる	ビール中びん(500ml)1～2本 日本酒1～2合 ウイスキー・シングル3杯
酩酊初期	110～150 mg/dl	気が大きくなる 大声でがなりたてる 怒りっぽくなる 立てばふらつく	ビール中びん(500ml)3本 日本酒3合 ウイスキー・ダブル3杯
酩酊極期	160～300 mg/dl	千鳥足になる 何度も同じことをしゃべる 呼吸が速くなる 吐き気・おう吐がおこる	ビール中びん(500ml)4～6本 日本酒4～6合 ウイスキー・ダブル5杯
泥酔期	310～400 mg/dl	まともに立てない 意識がはっきりしない 言語がめちゃめちやになる	ビール中びん(500ml)7～10本 日本酒7号～1升 ウイスキー・ボトル1本
昏睡期	410～500 mg/dl	ゆり動かしても起きない 大小便はたれ流しになる 呼吸はゆっくりと深い 死亡	ビール中びん(500ml)10本超 日本酒1升超 ウイスキー・ボトル1本超

CIWA-Arスコア

Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol
離脱症状の重症度を評価する尺度

評価項目(10項目)

悪心・嘔吐、振戦、発汗、不安、興奮、触覚
障害、聴覚障害、視覚障害、頭痛、見当識
障害

スコア解釈

0-9点:軽度、10-15点:中等度、16点以上:重
度。15点以上で薬物療法を強化。

評価頻度

重症例では数時間ごとに評価し、治療効
果を判定。

表5 CIWA - Ar (アルコール離脱症状重症度判定表) 20(30)(31)

1. 嘔気・嘔吐「胃の具合が悪いですか」「吐きましたか」 0 嘔気・嘔吐なし 1 嘔気を伴わない軽度の嘔気 2 3 4 嘔気を伴った間欠的嘔気 5 6 7 持続的嘔気	7. 聴覚障害「まわりの音が気になりますか、それは耳障りですか。そのせいで怖くなることはありませんか。不安にさせるような物音は聞こえますか。ここにはないはずの物音が聞こえますか。」 0 なし 1 物音が耳障りか、物音が驚くことがあるが軽度 2 上記の座状が中等度にある 3 上記の座状が高度である 4 軽度の幻聴 5 中等度の幻聴 6 高度の幻聴 7 持続性の幻聴
2. 振戦 上肢を前方に伸展させ手指を開いた状態で観察 0 振戦なし 1 軽度の振戦：視診で確認できないが、指先に指先を触れるとわかる 2 3 4 中等度振戦：上肢伸展で確認できる 5 6 7 高度振戦：上肢を伸展しなくても確認できる	8. 視覚障害「光がまぶしすぎますか。光の色が違って見えますか。光が目が痛むような感じがしますか。不安にさせるようなものが見えますか。ここにはないはずのものが見えますか。」 0 なし 1 光に対し非常に軽度に通感 2 軽度に通感 3 中等度に通感 4 やや重度の幻視 5 重度の幻視 6 非常に重度の幻視 7 持続性の幻視
3. 発汗 0 発汗なし 1 わずかに発汗が確認できるか、手紙が湿っている 2 3 4 前頭部に明らかな滴状発汗あり 5 6 7 全身の大量発汗	9. 頭痛・頭重感(めまい、ふらつきは評価しない)「頭に違和感がありますか。バンドで締め付けられるような感じがしますか。」 0 なし 1 ごく軽度 2 軽度 3 中等度 4 やや高度 5 高度 6 非常に高度 7 極めて高度
4. 不安「不安を感じますか」 0 不安なし、気楽にしている。 1 軽い不安を感じている 2 3 4 中等度の不安、または警戒しており、不安であると推測できる。 5 6 7 重篤なせん妄や統合失調症の急性期にみられるようなパニック状態と同程度の不安状態	10. 見当識・意識障害「今日は何日ですか。ここはどこですか。私は誰ですか。」 0 見当識は保たれていて、3つを連続して言うことが出来る。 1 3つを連続して言うことが出来ない。日付があいまい 2 日付の2日以内の間違い 3 日付の2日以上の間違い 4 場所か人に対する失見当識がある
5. 高体温 0 行動量の増加なし 1 行動量は普段よりやや増加している 2 3 4 やや著しき増加、そろそろ出ている 5 6 7 面談の大部分でウロウロ歩か、のたうち回っている	■合計点により次の通り対応します ・8-10点 …薬物投与せずに症状をモニターする ・10-15点…ベンゾジアゼピン投与が有効である ・15点以上…症状を抑える十分な量のベンゾジアゼピンの使用 ・離脱けいれんの既往のある患者は、離脱症状の重症度にかかわらずベンゾジアゼピンを使用する
6. 触覚障害「かゆみ、ピンでつかれるような感じ、やけどのような感じや感覚がでたり、皮膚に虫が這っているような感じがしますか」 0 なし 1 極端な、ピンでつかれる感じ、灼熱感、無感覚のいずれかが非常に軽度にある 2 上記座状が軽度にある 3 上記座状が中等度にある 4 やや重い体感幻覚(虫達い様感) 5 重い体感幻覚 6 非常に重い体感幻覚 7 持続性体感幻覚	

ベンゾジアゼピン系薬剤による治療

第一選択薬である。

ジアゼパム、クロナゼパム、ロラゼパム、ニトラゼパム等が標準的に使用される。GABA受容体を介して神経の過興奮を抑制。アルコールと交叉耐性。

投与方法

- ・ 症状トリガー法: $CIWA-Ar \geq 10$ で投与
- ・ 固定用量法: 定期的に投与し漸減

注意点

ふらつき、過鎮静、呼吸抑制に注意。

代替療法

ガバペンチン

抗てんかん薬として知られていますが、離脱症状の軽減効果が報告されている。ベンゾジアゼピン系薬剤の減量にも有用。

用量：300–1200mg/日、分3

デクスメデトミジン

α 2アドレナリン受容体作動薬。ICUでの重症離脱症状管理に使用。

鎮静効果があるが呼吸抑制が少ない。

用量：0.2–0.7 μ g/kg/時間

American Society of Addiction Medicine. 2020

チアミン(ビタミンB1)補充

投与の重要性

ウェルニッケ脳症の予防のため、糖質投与前にチアミンを投与。投与前にビタミンB1検査は出しておく。

投与量

チアミン250-500mg/日を静注または筋注。2-5日間以上継続。

ウェルニッケ脳症の三徴

眼球運動障害、運動失調、意識障害。早期治療が予後を左右する。

● アルコール使用症(依存症)の治療

①治療目標

・断酒

- ・ 治療目標は原則「断酒」
- ・ 飲酒コントロールに障害をきたす疾患のため、「適量(ほどほどに)飲む」ことは困難

・断酒以外の治療目標

- ・ 「断酒」以外の選択肢がないと治療関係が築けず治療中断となってしまう
- ・ 次善の策としての「減酒」
- ・ 二次被害を低減する治療的アプローチ「ハームリダクション」

②治療環境

・入院が必要なケース:

- 1) 通院では断酒に至れない、継続できない
- 2) 離脱管理が必要
- 3) 内臓障害や併存する精神疾患の症状が重篤
- 4) 住居設定・食事や服薬などの生活習慣の確立が必要

包括的治療の4本柱

薬物療法

抗渴望薬、嫌酒薬による生物学的アプローチ

心理療法

動機づけ面接、認知行動療法、心理教育

社会支援

自助グループ、就労支援、生活支援

家族支援

家族教育、CRAFT、家族療法

これら4つの要素を統合することで、最も効果的な治療が実現します。単一のアプローチでは不十分であり、患者の状態に応じて柔軟に組み合わせることが重要です。

図1 診断・治療選択のためのフローチャート

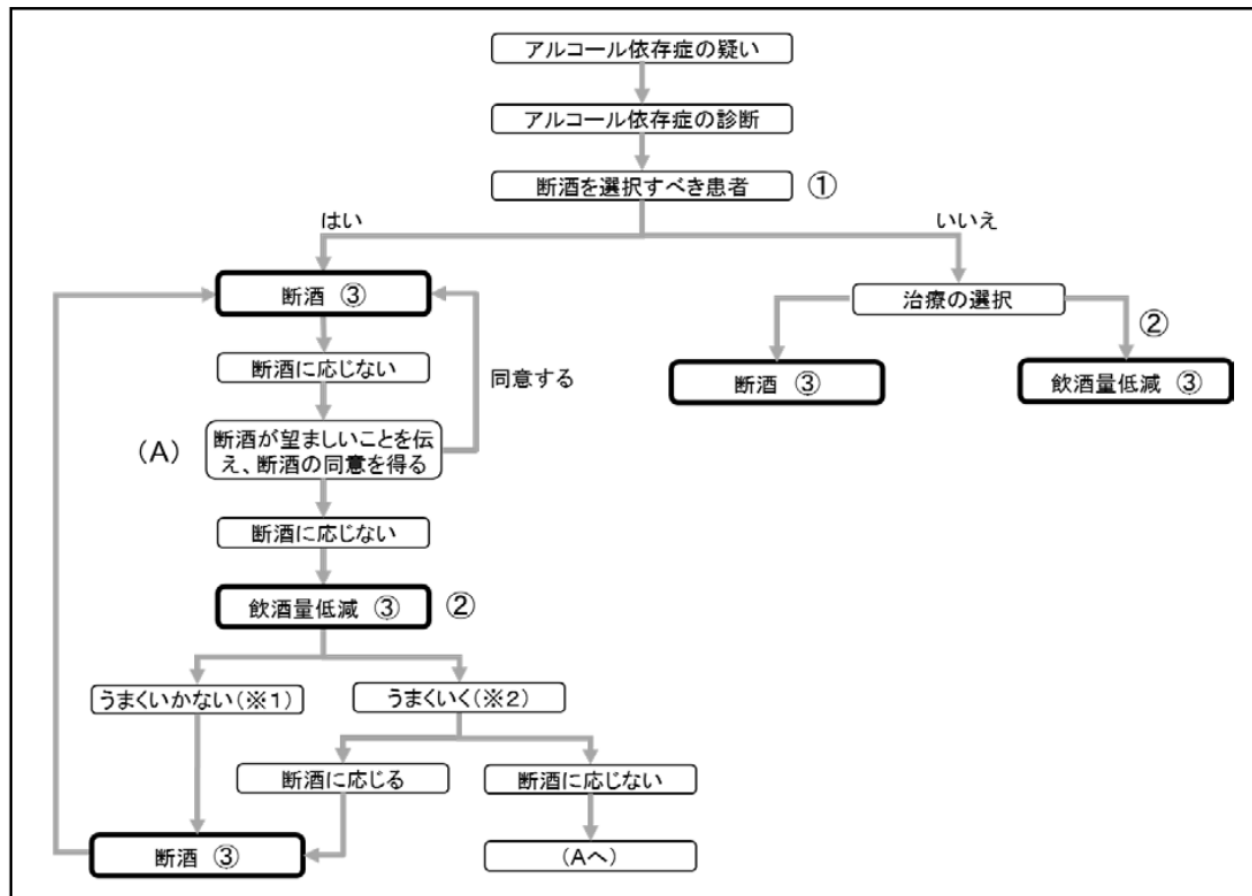


表6. SBIRT（簡易介入法）の全体像

1. スクリーニング (Screening)

アルコール関連問題が疑われる患者に対し、アルコール依存症や危険な飲酒の可能性をスクリーニングします。

- 対象 象: 酩酊患者、BAC 陽性の患者、外傷患者、アルコール関連の検査の異常や臓器障害を持つ患者、自殺企図・自傷にアルコールの関与が疑われる患者
身体的異常は軽度でも、精神面や生活面等で問題を有する患者(家族の苦悩は大きい)
- 実施場所: 病院の救急外来、地域連携・医療相談室、入院病棟、プレホスピタル、ポストホスピタルとしてのかかりつけ医、精神科病院、精神科クリニック、産業保健機関、その他の機関(保健所、福祉事務所、介護関係機関)など
- 検査法: CAGE、AUDIT-C、AUDITを実施し、陽性の場合にICD-10を実施する。フローチャートに従い、短時間で実施可能

2. ブリーフ・インターベンション（簡易介入）(Brief Intervention)

スクリーニングにてアルコール依存症や危険な飲酒があると判断された患者に対し、短時間のカウンセリングを行います。

- 『危険な飲 酒 』 : 節酒指導を行う
- 『アルコール依 存 症 』 : 断酒指導し、専門治療を紹介する
- 『軽度のアルコール依存症』 : 患者が断酒を拒否し、節酒を目標として選択する場合、節酒を注意深く経過観察し、継続不可になった時に断酒へ移行し、専門治療を紹介する

3. 専門治療への紹介 (Referral to Treatment)

アルコール依存症等の患者を専門治療に繋げます。

- アルコール依存症の場合
- 断酒指導が困難な場合
- 節酒が困難で、直ちに専門治療を受けないと心身の状態が悪化する場合等に専門治療を紹介する

附) 米国厚生省薬物乱用精神保健局 (SAMHSA) は、SBIRT を「危険な飲酒の人には早期に介入し、アルコール乱用や依存の人には集中的な専門治療へタイムリーで紹介する包括的で統合された公衆衛生的アプローチ」と定義³²⁾ し、2010 年に決定されたWHOの戦略にも採用され、国際的な取組の強化が求められている^{33) 34)}。

SBIRT

救急診療によりアルコール患者の急性症状が落ち着いたら、SBIRT(簡易介入法)を活用
アルコール関連問題を持つ患者が、救急受診あるいは入院してせん妄を発症した時は、心身の状態に関心をもつ「またとないチャンス」であり、介入の絶好の機会

CAGE

過去に次の経験がありましたか？

- (1)あなたは、自分の酒量を減らさねばならないと感じたことはありますか。(Cut down)
- (2)他の人に自分の飲酒について批判され、うるさいなと感じたことがありますか。(Annoyed by criticism)
- (3)自分の飲酒について、よくないと感じたり、罪悪感(後めたさ)をもったことがありますか。(Guilty feeling)
- (4)神経を落ち着かせるため、または二日酔いを治すために、朝まっさきに飲酒したことがありますか。
(Eye opener)

<診断>

- 1項目該当：「危険な飲酒」であり、節酒指導が必要
- 2項目以上該当：アルコール依存症の疑いあり、ICD-10I による診断へ

「危険な飲酒」と「アルコール依存症」のスクリーニング

表 8. AUDIT-C (AUDIT-C は AUDIT の最初の 3 項目による診断)

		0 点	1 点	2 点	3 点	4 点
1	あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか	飲まない	月に 1 度以下	月に 2~4 度	週に 2~3 度	週に 4 度以上
2	飲酒するとき、通常どのくらいの量を飲みますか (以下ドリンクの目安) 「日本酒」 1 合=2 ドリンク 「ビール」 中ビン 500ml=2 ドリンク 「ウイスキー」 水割りダブル 1 杯=2 ドリンク 「焼酎(25°)」 0.5 合=2 ドリンク 「ワイン」 グラス 1 杯=1.5 ドリンク	1~2 ドリンク	3~4 ドリンク	5~6 ドリンク	7~8 ドリンク	10 ドリンク以上
3	一度に 6 ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか	ない	月に 1 度未満	月に 1 度	週に 1 度	ほぼ毎日

●合計得点：男性 5 点、女性 4 点以上は「危険な飲酒」であり、ICD-10 による診断へ

●合計得点：上記基準以下は年一回のチェックを

表 10 WHO の推奨する飲酒のスクリーニングテスト AUDIT

※以下の 1~10 の質問に当てはまる項目の数字の合計で判定します(判定は下表参照)

- あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか？
0. 飲まない 1. 1 カ月に 1 度以下 2. 1 カ月に 2 ~ 4 度 3. 1 週に 2 ~ 3 度 4. 1 週に 4 度以上
- 飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか？ (下表のドリンク数の計算式を参照してください)
0. 1 ~ 2 ドリンク 1. 3 ~ 4 ドリンク 2. 5 ~ 6 ドリンク位 3. 7 ~ 9 ドリンク 4. 10 ドリンク以上
- 1 度 に 6 ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか？
0. ない 1. 1 カ月に 1 度未満 2. 1 カ月に 1 度 3. 1 週に 1 度 4. 毎日あるいはほとんど毎日
- 過去 1 年間に、飲み始めると止められなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0. ない 1. 1 カ月に 1 度未満 2. 1 カ月に 1 度 3. 1 週に 1 度 4. 毎日あるいはほとんど毎日
- 過去 1 年間に、普通だと行えることを飲酒していたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0. ない 1. 1 カ月に 1 度未満 2. 1 カ月に 1 度 3. 1 週に 1 度 4. 毎日あるいはほとんど毎日
- 過去 1 年間に、深酒の後体調を整えるために、朝迎え酒をせねばならなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0. ない 1. 1 カ月に 1 度未満 2. 1 カ月に 1 度 3. 1 週に 1 度 4. 毎日あるいはほとんど毎日
- 過去 1 年間に、飲酒後悪寒や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0. ない 1. 1 カ月に 1 度未満 2. 1 カ月に 1 度 3. 1 週に 1 度 4. 毎日あるいはほとんど毎日
- 過去 1 年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0. ない 1. 1 カ月に 1 度未満 2. 1 カ月に 1 度 3. 1 週に 1 度 4. 毎日あるいはほとんど毎日
- あなたの飲酒のために、あなた自身が他の誰かがけがをしたことがありますか？
0. ない 2. あるが、過去 1 年にはなし 4. 過去 1 年間にあり
- 肉親や親戚、友人、医師、あるいは他の健康管理にたずさわる人が、あなたの飲酒について心配したり、飲酒量を減らすように勧めたりしたことがありますか？
0. ない 2. あるが、過去 1 年にはなし 4. 過去 1 年間にあり

ドリンク数の計算式： アルコール度数(%) × アルコール飲料の量(ml) × 8 ÷ 10000 = ドリンク数

例 1 : 6% のビール (350ml) を 3 本飲む場合

$$(6 \times 350 \times 3) \div 8 \div 10000 = 5.04 \text{ ドリンク}$$

例 2 : 7% のビール (500ml) を 2 本、6% の酎ハイ (500cc) を 3 本、1 日に飲む場合

$$(7 \times 500 \times 2 \times 8 \div 10000) + (6 \times 500 \times 3 \times 8 \div 10000) = 12.8 \text{ ドリンク}$$

例 3 : 焼酎、ウイスキー、日本酒をガラス瓶や紙パックやプラスチック製の瓶で購入している場合

$$\text{アルコールの度数}(\%) \times 1 \text{ 瓶当たりの量}(\text{ml}) \div \text{飲み切る日数} \times 8 \div 10000 = \text{ドリンク数}$$

判定 各項目の合計得点： 1 0 点未満・・・危険の少ない飲酒

1 0 点以上・・・危険な飲酒

2 0 点以上・・・アルコール依存症の疑い

関わり方

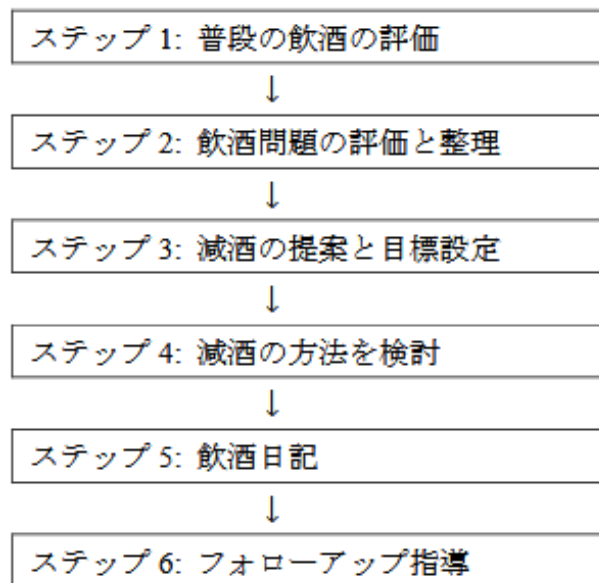
重要な姿勢

- ・ 非審判的態度
- ・ 長期的視点
- ・ 再発を前提とした支援
- ・ 患者の強みに注目

避けるべき態度

- ・ 説教や叱責
- ・ 完璧主義の押し付け
- ・ 家族への過度な期待
- ・ 早急な結果を求める

節酒指導



減酒指導のポイント

- ・指導すれば効果は現れる。内容よりも何かをした、ということが大切。
- ・評価のための聞き取りだけでも、酒量が減ることが多い。
- ・減酒目標は、達成可能なものにする。
- ・減酒目標は、押しつけるのではなく、対象者に決めていただく。
- ・飲酒習慣を変えるのは大変だが、がんばってみよう、と共感・激励する。
- ・その気になれば目標達成は可能だと、励ます。
- ・フォローアップ時に飲酒量が減っていなくとも、再度チャレンジしてみるよう励ます。
- ・目標が高すぎると思われた場合には、フォローアップ指導時に目標を再設定してもよい。

- アルコール依存症の薬物療法

- 1) 抗酒薬

- ジスルフィラム(ノックビン)、シアナミド(シアナマイド)
 - アルデヒド脱水素酵素(ALDH)阻害薬

- 2) 断酒補助薬

- アカンプロサート(レグテクト)
 - NMDA受容体を介する神経伝達を阻害し飲酒渴望を抑制する
 - 断酒を目標とする依存症者の断酒を補助する効果

- 3) 飲酒量低減薬

- ナルメフェン(セリンクロ)
 - μ / δ オピオイド受容体を阻害、 κ オピオイド受容体を部分作動
 - アルコールが引き起こす「快刺激」を抑制し、飲酒量を低減させる

* アルコール依存症治療において、薬物療法はあくまで補助的な治療

ジスルフィラム

1

作用機序

アルデヒド脱水素酵素を阻害し、アセトアルデヒドを蓄積させる。

2

ジスルフィラム反応

顔面紅潮、動悸、悪心、嘔吐、頭痛、呼吸困難などが出現。

3

使用上の注意

患者の同意と理解が必須。心疾患、肝疾患では慎重投与。アルコール含有食品・薬剤も避ける。

4

用量

200-500mg/日、1日1回。効果は服用後2週間程度持続。

アカンプロサート(レグテクト)

作用機序

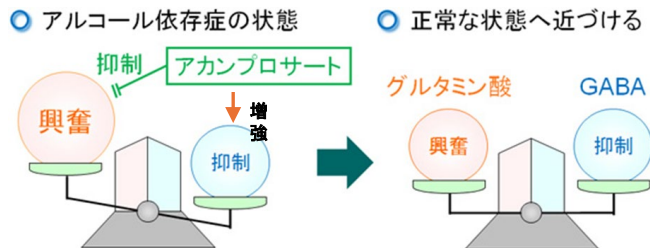
グルタミン酸神経系を抑制し、GABA神経系を賦活することで、神経伝達物質のバランスを正常化。

用量

1998mg/日(体重60kg以上)、分3。食後投与。腎機能に応じて減量が必要。

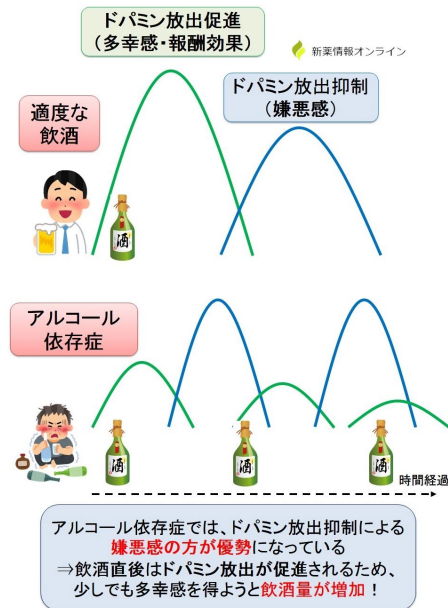
効果

断酒率の向上、飲酒日数の減少が臨床試験で確認されている。副作用は下痢が最も多いが、一般的に忍容性は良好。



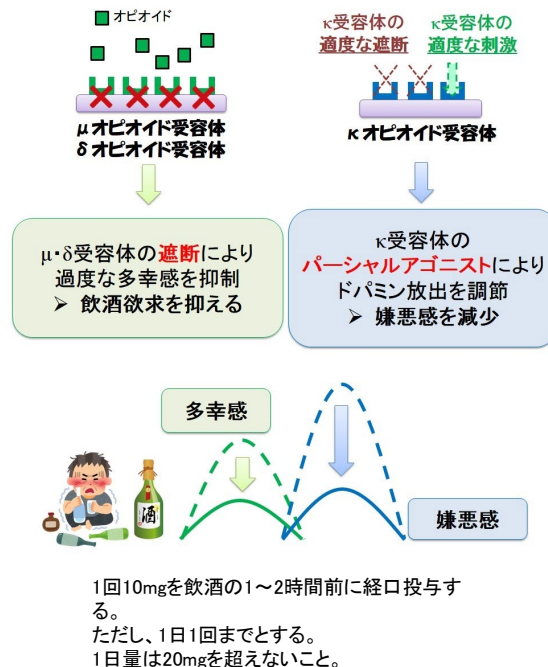
ナルメフェン(商品名セリンクロ)

日本では2019年より発売



セリンクロ(ナルメフェン)の作用機序(イメージ)

新薬情報オンライン



特徴

「飲酒量低減」を目標とする新しいアプローチ。完全断酒が困難な患者に有用。

作用機序

μ & δ オピオイド受容体拮抗作用とκ オピオイド受容体部分作用により、報酬系を調節。アルコール摂取による過剰な幸福感を得ることを防ぎつつ、嫌悪感についても抑制をかける。その結果、飲酒欲求を低下させ、飲酒量を低減させることができると考えられている。

新薬情報オンライン

精神科併存症



うつ病

約30-40%に併存。アルコールによる一時的な気分改善が依存を強化。



不安障害

社交不安障害やパニック障害との併存が多く、自己治療的な飲酒パターンが見られる。



ADHD

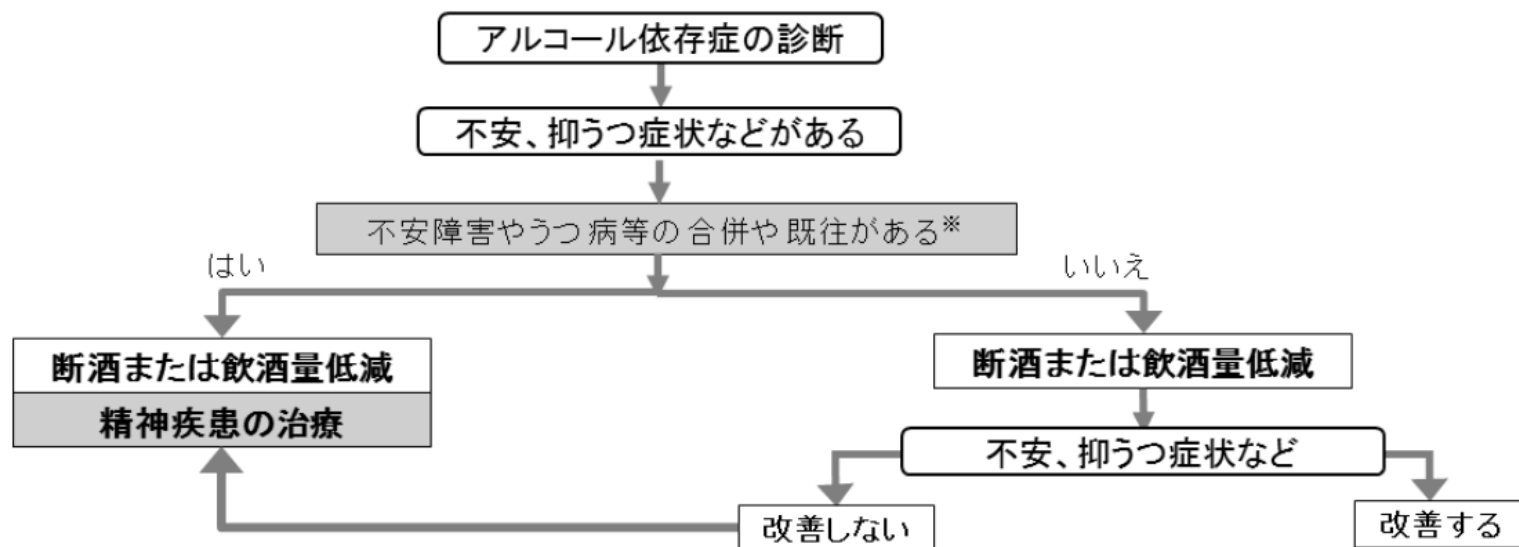
衝動性の高さが飲酒行動のコントロール困難さと関連する。



認知症

アルコール性認知症やウェルニッケ・コルサコフ症候群のリスクがある。

アルコール依存症に不安、抑うつ症状が認められる場合のフローチャート



新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドラインに基づいたアルコール依存症の診断治療の手引き 第1版 2018.

● アルコール依存症の非医療的社会資源の活用

① 自助グループ

- AA(アルコホリクス・アノニマス)
 - ・参加者の匿名性を重視
 - ・12ステップ・プログラムによるミーティング
- 断酒会
 - ・酒害者(酒に悩む人)による酒害者のための自助組織
 - ・国内各地に支部を持つ全国組織
 - ・本人及び家族が所属
 - ・実名での参加

② 民間リハビリテーション施設

- 自助グループにつながりアルコールを必要としない生活習慣確立を目指す非医療的社会資源
- 通所施設、入所施設の2通り

1. 私たちはアルコールに対し無力であり、思い通りに生きていけなくなっていたことを認めた。
2. 自分を超えた大きな力が、私たちを健康な心に戻してくれると信じるようになった。
3. 私たちの意志と生き方を、自分なりに理解した神の配慮にゆだねる決心をした。
4. 恐れずに、徹底して、自分自身の棚卸しを行ない、それを表に作った。
5. 神に対し、自分に対し、そしてもう一人の人に対して、自分の過ちの本質をありのままに認めた。
6. こうした性格上の欠点全部を、神に取り除いてもらう準備がすべて整った。
7. 私たちの短所を取り除いて下さいと、謙虚に神に求めた。
8. 私たちが傷つけたすべての人の表を作り、その人たち全員に進んで埋め合わせをしようとする気持ちになった。
9. その人たちやほかの人を傷つけない限り、機会あるたびに、その人たちに直接埋め合わせをした。
10. 自分自身の棚卸しを続け、間違ったときは直ちにそれを認めた。
11. 祈りと黙想を通して、自分なりに理解した神との意識的な触れ合いを深め、神の意志を知ることと、それを実践する力だけを求めた。
12. これらのステップを経た結果、私たちは霊的に目覚め、このメッセージをアルコールに伝え、そして私たちのすべてのことにこの原理を実行しようと努力した。

否認のメカニズムと理解

否認は依存症の中核症状であり、心理的防衛機制。

「私は依存症ではない。いつでもやめられる」

「問題があるのは認めるが、それほど深刻ではない」

「他の人に比べれば、まだマシな方だ」

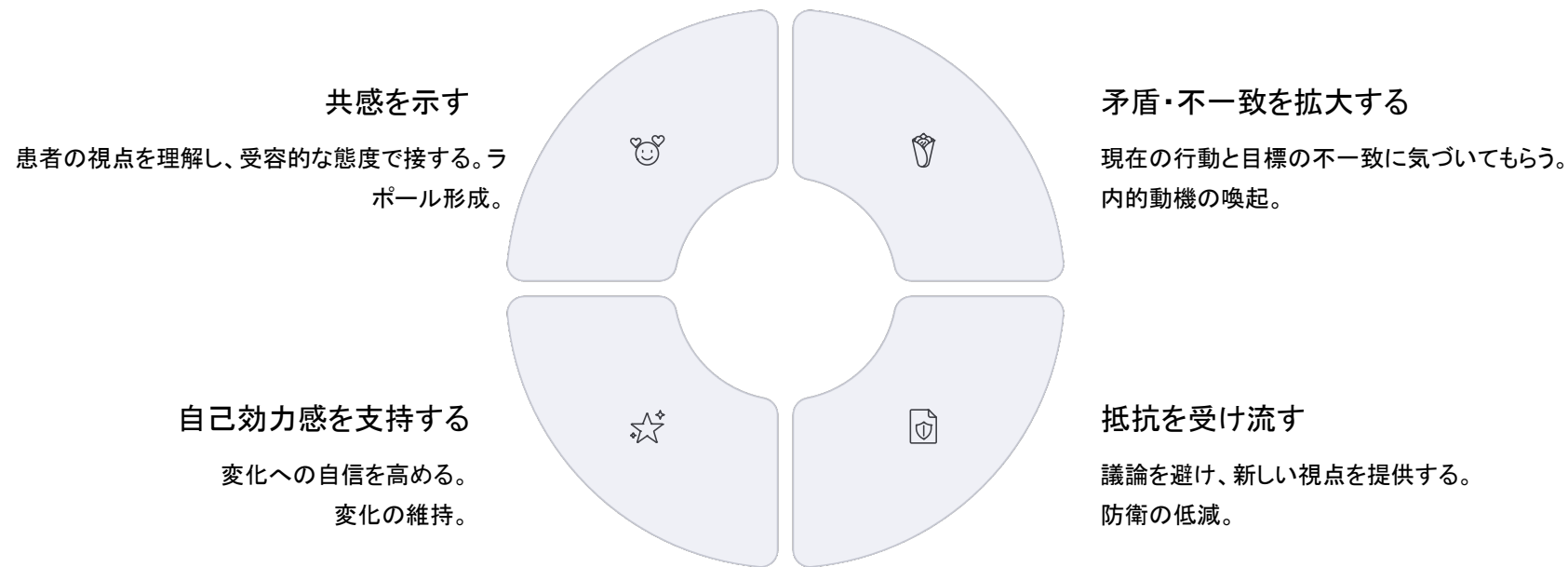
否認を「打ち破る」のではなく、「共に探索する」姿勢が重要。

- アルコール依存症を早期に治療・支援につなげる取組

動機付け面接(MI: Motivational Interviewing)

- 動機付け面接とは、協働的なスタイルによる会話によって、相談者自身が変わるための動機付けを高め、行動変容を促す会話の方法
- 受容・傾聴を基本とした「来談者中心的」な要素に、「目標指向的」な要素を加えた面接スタイル
- 来談者の発言には、現状を変えたくないという方向性の発言(維持トーク)と、現状を変化させようという方向性の発言(チェンジトーク)の両方が含まれている(両価性)。
- 動機付け面接は、「両価性」を含んだ来談者の発言の中に含まれている(つまり、もともと本人の中にある)「チェンジトーク」を選択的に膨らませ、本人から「変わろう」という気持ちを引き出す面接スタイル。

動機づけ面接(MI)の4原則



動機付け面接のスピリット(PACE)

P: 協働 (Partnership)

- 来談者と協力して問題解決にあたる

A: 受容 (Acceptance)

- 好ましくない考えや行動であっても、来談者が治療関係の中で表明することを許容する

C: 思いやり (Compassion)

- 来談者の福祉向上を第一優先とする

E: 喚起 (Evocation) (エンパワメント (Empowerment))

- 来談者の本来持っている内的な動機を引き出す

(クライアントが持っている能力や強みに気づき活用するのを手助けする)

動機付け面接の基本技法: OARS技法



Open questions (開かれた質問)

「どのように感じていますか?」「何が心配ですか?」など、詳しい説明を促す質問を行う。



Affirmations (是認)

患者の強みや努力を認め、肯定的なフィードバックを提供。



Reflective listening (聞き返し)

患者の言葉を言い換えて返すことで、理解を深める。



Summaries (要約)

会話の内容を定期的にまとめ、重要なポイントを強調。

OARSを使った会話の例

患者: 何度も禁酒にはチャレンジしたんだけど、全然続かないんだよね



- | | |
|--|--------------|
| ①医者: 禁酒しようと思ったけど、また飲んでしまったときはどんなお気持ちでした？ | 開かれた質問 |
| ②医者: 何度も禁酒にはチャレンジしたけど続かなかった... | 単純な聞き返し |
| ③医者: 何度も禁酒にはチャレンジしたけどうまくいなくてあきらめ気味... | 複雑な聞き返し |
| ④医者: うまくいかなかったのに、何度もチャレンジしていらっしゃるんですね... | 単純な聞き返しによる是認 |
| ⑤医者: うまくいく方法があればもう一度試してみたい... | 複雑な聞き返し |
| ⑥医者: 何度も失敗しているのに禁酒しようと思うのはどうしてなのですか？ | 開かれた質問 |

ケース：外来での動機づけ面接

38歳女性、夫の勧めで受診。「夫が心配しすぎている」と訴え。

医師：「ご主人が心配されているとのことですが、あなた自身はどう感じていますか？」

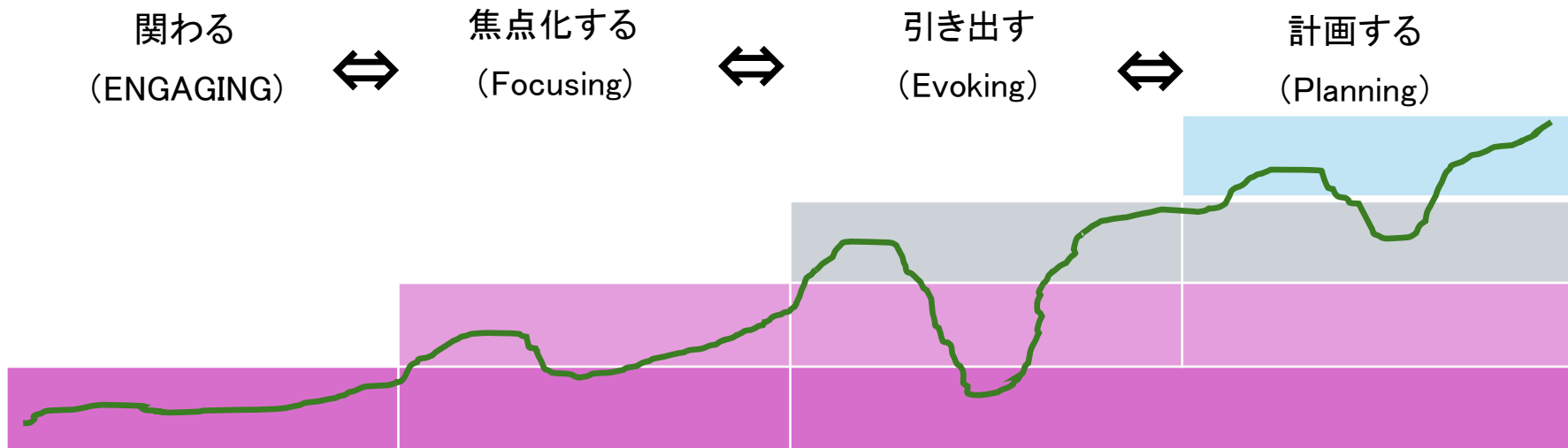
患者：「確かに、最近は毎晩飲んでいます。でも、ストレス解消には必要なんです」

医師：「ストレス解消に役立っているのですね。一方で、何か困っていることはありませんか？」

患者：「実は...朝起きるのがつらくて、子供の世話が十分にできていないかもしれません」

動機付け面接(MI)の4つのプロセス

1. 関わる(Engaging): 共感し信頼関係を築く
2. 焦点化する(Focusing): 的を絞る(進むゴールを決定する)
3. 引き出す(Evoking): 動機を引き出す
4. 計画する(Planning): ゴールを目指す計画を立てる



物質使用障害治療プログラム SMARPP(認知療法的アプローチ)

1. なぜアルコールや薬物をやめなくてはいけないの？
2. **引き金**と欲求
3. 薬物・アルコールのある生活からの回復段階 — 最初の1年間
4. あなたの**まわりにある引き金**について
5. あなたの**なかにある引き金**について
6. 薬物・アルコールを使わない生活を送るための注意事項
7. 依存症ってどんな病気？
8. これからの**生活のスケジュールを立ててみよう**
9. 覚醒剤の身体・脳への影響
10. 精神障害と薬物・アルコール乱用
11. 合法ドラッグとしてのアルコール

12. 危険ドラッグと睡眠薬・抗不安薬
13. マリファナはタバコより安全？
14. 薬物・アルコールに問題を抱えた人の予後
15. **回復のために— 信頼、正直さ、仲間**
16. アルコールをやめるための三本柱 — 抗酒剤について
17. アルコールによる身体の障害
18. **再発を防ぐには**
19. **再発の正当化**
20. アルコールによる脳・神経の障害
21. 性の問題と休日の過ごし方
22. **あなたを傷つける人間関係**
23. **「強くなるより賢くなれ」**
24. あなたの**再発・再使用のサイクルは？**

「強さ」ではなく「賢さ」を身に付けるのが目標

● 家族支援

① 家族支援の必要性

- ・ 家族支援が本人の医療アクセス・治療継続率を高める
- ・ 家族は本人への対応に疲弊しており支援が必要である
- ・ 家族に対してはこれまで頑張っただけを「**労う**」ことが大切

② **イネイブリングを辞める**必要性

- ・ 患者に対する「尻ぬぐい」や「説教」などの行為をイネイブリングという
- ・ 家族がイネイブリングを止めることで、患者が自分自身の問題と向き合い、治療の必要性を自覚するきっかけとなる
- ・ 家族はイネイブリングではなく、家族自身の生活を大切にすることが重要
- ・ 行ってきた**イネイブリング行為を責めるのではなく、「効果的なかわり方」を伝える**

③ 家族支援のための社会資源

- ・ 精神保健福祉センター
- ・ 依存症家族のための自助グループ
 - ・ アラノン (Al-Anon)
 - ・ 断酒会家族会

● CRAFT: Community Reinforcement And Family Training (家族支援のためのプログラム)

- アルコール・薬物依存症者と家族のためのプログラム
- 家族など依存症者の**周囲にいる人が自らのコミュニケーションを変える**ことで、**対立を招かず治療につなげる**ことが可能
- 家族が持っていない力を教え込むのではなく、「**すでに持っているけれど使えていない力**」が使えるよう**トレーニング**する
- たとえ依存症者が治療につながらなくても、問題行動が減ったり、家族がもっと楽に暮らせる(感情・身体・対人関係面で)効果がある

②CRAFTで行うこと

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. 状況をはっきりさせる | 5. イネイブリングをやめるとは |
| 2. 安全第一(暴力への対策) | 6. あなた自身の生活を豊かにする |
| 3. コミュニケーションを変える | 7. 治療を勧める |
| 4. 望ましい行動を増やす方法 | |

再発予防計画

高リスク状況の特定

- ・ 特定の場所(居酒屋、友人宅)
- ・ 感情状態(怒り、孤独、疲労)
- ・ 対人関係(特定の人との接触)
- ・ 時間帯(仕事終わり、週末)

対処スキル

- ・ 回避戦略(場所を避ける)
- ・ 代替行動(運動、趣味)
- ・ サポート活用(電話相談)
- ・ 認知的対処(セルフトーク)

書面化した計画を作成し、常に携帯することを推奨する。

覚醒剤(アンフェタミン、メタンフェタミン)

- 覚醒剤の薬理作用

- ・ 脳内報酬系のドーパミン神経終末のドーパミン再取り込み部位に作用する
- ・ 強い精神依存を形成するが、身体依存はほとんどない
- ・ 覚醒剤取締法により規制

- 覚醒剤乱用の歴史

- ① 第一次覚醒剤乱用期

- ・ うつ病の治療薬として処方され、「ヒロポン」という滋養強壮薬として薬局でも販売されていた
 - ・ 第二次世界大戦中は夜間労働に際して眠気除去目的で用いられる軍需品だった
 - ・ 終戦とともに市中に流出し、大学生を中心に急激に乱用が拡大した
 - ・ 1951年覚醒剤取締法制定で一時的に収束

- ② 第二次覚醒剤乱用期

- ・ 覚醒剤取締法制定により「違法」となり実態は地下に潜行し裏社会で流通
 - ・ 1970年代、暴力団が資金源としたことで対象者が拡大

- ③ 第三次覚醒剤乱用期

- ・ 第二次が収束しないまま、静脈注射にかわる加熱吸煙による摂取方法が広がり、陰うつなイメージが刷新されたこともあり、新たな乱用層を獲得し乱用層のすそ野が拡大

覚醒剤(アンフェタミン、メタンフェタミン)

● 覚醒剤対策の課題

① 厳罰政策の限界

- 2000年代以降、全体としては緩徐な減少傾向
- しかし、初犯者が顕著に減少しているのに対し、再犯者の減少率は低い
- 服役する度に再犯のリスクが高まり、同じ人物が繰り返し逮捕されている



- 服役の度に就労の機会や健康的なコミュニティとのつながりを失う

② ハイリスク・グループとしてのLGBT

- MSM(men who have sex with men)の人々のコミュニティでの覚醒剤使用の広がり
- コンドームを使用しない肛門性交、注射器共有⇒HIV、HCVの感染リスク
- MSMかつHIV陽性者に対する二重のスティグマ⇒医療・相談支援からの阻害

覚醒剤

● 覚醒剤関連精神疾患

①覚醒剤中毒

- ・中枢神経系への作用: 多幸感・高揚感、集中力向上、疲労感・食欲の低下、睡眠欲求の減少
- ・交感神経刺激作用: 血圧上昇、頻脈、呼吸数増加
- ・過剰摂取の際の精神運動興奮、焦燥感、錯乱、常同行為、せん妄を伴う意識障害、脳内出血、循環虚脱、横紋筋融解症

②覚醒剤使用症

- ・物理的に入手困難な場合に断薬していることは比較的容易
- ・ちょっとした引き金で渴望のスイッチが入り、再使用に至ってしまう

③覚醒剤誘発性精神疾患

- ・覚醒剤の連用により生じる幻聴や被害関係妄想などの精神症症状
- ・通常、覚醒剤使用停止、抗精神病薬投与により1～4週間で消失
- ・精神症症状が出現した場合、少量の覚醒剤使用でも容易に精神症症状が出現する(逆耐性)

④覚醒剤残遺性・遅発性精神症

- ・残遺性精神症: 使用停止後数か月後に幻覚・妄想等の精神症症状が出現
- ・遅発性精神症: 長期間不使用にも関わらず、不眠・ストレス、飲酒を契機とした精神症状が出現(フラッシュバック)

覚醒剤

● 覚醒剤使用症の治療

①急性期治療

- ・精神症症状の治療: **抗精神病薬**
- ・離脱管理、渴望期: 最終使用から1～2日は強い眠気・過眠傾向、3日目以降～2週間は食欲増進、易興奮性・易怒性亢進、渴望の強まり(再使用のリスク)

②リハビリテーション期治療

- ・治療目標: 断薬
- ・治療環境: 医療機関(通院・入院)
非医療機関(精神保健福祉センター、自助グループ、民間リハビリテーション施設)
- ・治療内容: SMARPP(集団・個人)、依存症デイケア
- ・治療環境: 医療機関(通院・入院)
非医療的社会資源(精神保健福祉センター、自助グループ、民間リハビリテーション施設)

③家族支援

- ・ナラノン(Nar-Anon)、DARC利用者の家族会、全国薬物依存症者家族連合会(やっかれん)

④覚醒剤依存症治療における医師の心得

- ・「より**長くつながり続けること**」、「より**広くつながる機会**をつくること」
- ・治療の場における**安心・安全の確保**

覚醒剤

- 非医療的社會資源

- ①精神保健福祉センター

- SMARPP (Serigaya methamphetamine relapse prevention program)
 - Voice Bridge Project

- ②自助グループ

- NA (ナルコティクス・アノニマス)

- ②民間リハビリテーション施設

- DARC (Drug Addiction Rehabilitation Center)

鎮静薬・睡眠薬・抗不安薬(ベンゾジアゼピン受容体作動薬)

● ベンゾジアゼピン受容体作動薬

- ・ γ アミノ酪酸(GABA)の神経伝達を亢進し中枢神経系を抑制する
- ・ 依存(精神依存・身体依存)を形成しやすく、常用量依存となりやすい
- ・ 短時間作用型の薬剤が依存を形成しやすい



エチゾラム(デパス)、ゾルピデム(マイスリー)、
トリアゾラム(ハルシオン)、フルニトラゼパム(サイ
レース、ロヒプノール)

● 過量服薬時の作用

- ・ 運動失調、構音障害、意識障害
- ・ 脱抑制、暴力・自傷行動(軽度の意識障害時)
- ・ 昏睡(→筋挫滅、腎不全)、自発呼吸抑制(嘔吐→吐しゃ物による窒息)



ベンゾジアゼピン系
睡眠薬に代わるもの

● 離脱症状

- ・ 反跳性の不眠・不安
- ・ 離脱痙攣(多くの場合、服用中断後1～2週間で消失)

オレキシン受容体拮抗薬

- ・ スボレキサント(ベルソムラ)
- ・ レンボレキサント(デエビゴ)
- ・ ダリドレキサント(クービビック)

● 依存症の治療

- ・ 急性期: 中時間～長時間作用型の薬剤に置き換えた上で漸減する
- ・ リハビリテーション期: アルコール依存症等と同様の集団・個人での再発防止プログラム

大麻

- 薬理作用
 - **THC**(tetrahydrocannabinol)
 - ・強い中枢神経作用を有す(**中枢神経抑制薬・幻覚薬**)
 - ・知覚変容、多幸感、痛覚低下、幻覚誘発
 - **CBC**(cannabidiol)
 - ・抗けいれん作用、抗炎症作用、免疫増強作用
- 大麻取締法
 - ・ THC含有率が低い部位(種子・茎)以外を「大麻」と定義し、所持改正法・営利・譲渡を禁止していた
 - ・ 検挙者数増加により、2023年改正され、医薬品利用が解禁されると共に、使用罪が新設された
- 健康被害
 - **健康被害については十分なエビデンスが集積しているとは言えない状況**
 - ・ 未成年の使用により、将来うつ病に罹患するリスクや自殺行動に及びリスクが高まる可能性
 - **既に存在する統合失調症の症状を悪化させる可能性**

大麻

- 大麻関連症
 - ・ 大麻中毒
 - ・ 中枢神経系を抑制し、判断力・注意力低下
 - ・ 夢幻状態(考えがまとまりなく自由に展開する)、離人感
 - ・ 聴覚や視覚の変容感
 - ・ 結膜充血、頻脈、食欲亢進、口腔内乾燥、血圧上昇
- 大麻離脱
 - ・ 比較的軽度であるが、数週間大量・頻繁に使用した場合、使用中止12時間より不眠、攻撃性亢進、抑うつ気分、悪心、食欲低下が数日間持続することがある
- 大麻使用症
 - ・ 覚醒剤に比べるとコントロール障害を引き起こしにくいと考えられているが依存性がないわけではない
 - ・ 長期間の使用、リキッドやワックスとなどTHC含有濃度が高いものを使用するものは依存症のリスクが高まる
 - ・ THC暴露総量と依存症罹患リスクは正の相関関係

市販薬

- 市販薬乱用状況

- ・ 2018年以降、依存症専門医療機関では若者を中心に市販薬関連症患者が急増している
- ・ ドラッグストアの店舗拡大、処方薬の市販薬化の推進、インターネット販売の規制緩和(2014年)などが影響

- 乱用頻度の高い市販薬の含有成分と薬理作用

- ①鎮咳薬・感冒薬

- ・ジヒドロコデイン:麻薬取締法で規制されているオピオイド
 - ・メチルエフェドリン:覚醒剤取締法で規制されている覚醒剤原料
 - ・デキストロメトルファン(鎮咳薬):解離性麻酔薬類似作用

低濃度であれば市販薬の含有が許される

- ②睡眠導入薬・抗アレルギー薬

- ・ジフェンヒドラミン:抗ヒスタミン成分

コカイン

- 薬理作用

- コカの木に含有されるアルカロイド
- 局所麻酔としての作用、中枢神経興奮薬としての作用
- 精神依存作形成能は強いが身体依存の形成は殆ど認めない
- 覚醒剤より作用時間が短い
- 薬理作用招待時に虚脱感・疲労感を感じやすい
- 向精神薬取締法で規制

幻覚薬

- 薬理作用

- 薬剤により作用機序や作用部位には違いがあるが、セロトニンの作用を阻害することで幻覚を生じさせる(ケタミンはNMDA型グルタミン酸受容体に作用する)
- 催幻覚作用・知覚変容作用は強いが、身体依存・精神依存はそれほど強くない

- 幻覚薬の種類

- LSD、MDMA、シロシビン(マジックマッシュルーム等幻覚誘発性キノコの主成分)、PCP、ケタミン、5-MeO-DIPT

危険ドラッグ

- 危険ドラッグとは
 - 違法薬物成分の化学構造式の側鎖に微妙改変を行うことで法規制を逃れた薬物
 - 違法薬物と同様の薬理作用を有する
- 危険ドラッグの乱用拡大
 - 2011年頃より急増
 - 規制強化を行うも、化学構造の側鎖にさらに変化を加え規制を逃れるイタチごっこの状態
 - **2014年薬事法改正**により安全性未確認物質の販売規制 ⇒ **急速に鎮静化**
 - 近年、大麻取締り強化により、大麻草茎由来のcannabidiol (CBD) 成分を改変した合成カンナビノイド製品が出現している
- 危険ドラッグの乱用拡大
 - 2011～2015年頃: 合成カンナビノイド系成分、合成カチノン系成分が主流
 - ⇒ 誘発性精神疾患も大麻・覚醒剤誘発性精神疾患と類似した症状
 - それ以降: 幻覚薬、オピオイド成分含有の製品の流通
 - ⇒ **誘発性精神疾患の症状も多様化(危険度は増している)**

オピオイド

- オピオイドとは

- ケシ科植物由来のアルカロイド、及びその成分から合成された一連の化合物
- 中枢神経抑制薬
- 強力な鎮静作用、陶酔感、多幸感、安堵感
- 身体依存・精神依存ともに強力な依存形成能を有する
- 麻薬及び向精神薬取締法により規制・管理される

- オピオイドの種類

- ①麻薬

- ・医療的有用性のない薬剤:ヘロイン
 - ・医療的有用性のある薬剤:モルヒネ、オキシコドン、フェンタニル、メサドン、タペンタドール

- ②向精神薬

- ・ペンタゾシン(ソセゴン)、ブプレノルフィン(レンペタン)

- ハームリダクション

- 1980年代以降、欧州で静脈注射によるヘロイン使用者によりHIV感染拡大、過剰摂取による死亡事故が問題化
- ハームリダクション政策(物質使用が二次的に引き起こす弊害を低減させる公衆衛生政策)

オピオイド

- オピオイド関連症

- ①オピオイド中毒

- ・初回使用時: 悪心・嘔吐
 - ・過量摂取時: 自律神経系症状 (自発呼吸抑制、胃腸蠕動抑制、血圧低下、徐脈、縮瞳)
 - ・耐性が生じると使用量が増加し致死量を超え死に至ることがある

- ②オピオイド離脱

- ・下痢・腹痛、身体各部の疼痛
 - ・不安・焦燥感
 - ・発汗、発熱、悪寒、頻脈、散瞳、くしゃみ、欠伸、嘔吐→「自律神経の嵐」「コールド・ターキー」
 - ・通常7日～14日で消失
 - ・離脱軽減にメサドン (持続性強オピオイド) が用いられる (日本では離脱治療への使用は不可)

オピオイド

- オピオイド使用症

- ・治療薬として処方されたオピオイドを医師の処方どおりに服用している場合には、耐性や離脱を生じたとしても、使用症とは診断しない

- ①有害な使用を疑わせる兆候

- 1) 受診予約日を前倒して早めに受診する
- 2) 精神的苦痛の緩和など本来の処方目的(疼痛緩和)と異なる用途に使用する

- ②依存症を疑わせる兆候

- 1) 虚偽の訴えにより必要以上の量の処方を求める
- 2) オピオイド処方をめぐり医師と衝突を繰り返す、医師に処方を強要する
- 3) 複数の医療機関からオピオイドの処方を求める
- 4) 処方箋の偽造、盗んで入手しようとする
- 5) 錠剤を粉砕し、経鼻吸引や加熱吸煙、静脈注射など別の摂取経路で使用する
- 6) 不正なルートから違法なオピオイドを入手し処方では足りない分を補う

吸入剤

- 種類と薬理作用、乱用状況
 - ・ 揮発性溶剤:トルエン、シンナー
 - ・ 炭化水素系ガス:ボタンガス(カセットコンロのボンベ、ガスライター補充用ボンベ)
 - ・ 中枢神経抑制作用
 - ・ 法令による規制はない
 - ・ 1980年代までは10代の「ゲートウェイ・ドラッグ」だったが、一貫して減少傾向
- 吸入剤関連症
 - ・ 中枢神経抑制作用、催幻覚作用
 - ・ 中毒症状:万能感、夢幻用体験、幻視、変形視、意識障害、自発呼吸抑制
 - ・ 幻覚を伴う誘発性精神疾患
 - ・ 長期乱用⇒脳室拡大・小脳萎縮を伴う器質性精神疾患

注意欠如多動症治療薬

- 種類と薬理作用、乱用状況
 - ・ メチルフェニデート(リタリン、コンサータ)(麻薬及び向精神薬取締法の第一種向精神薬)
 - ・ リスデキサンフェタミン(ビバンセ)(覚醒剤取締法)
 - ・ 中枢神経興奮薬としての作用
 - ・ メチルフェニデートは、かつてはうつ病にも処方が求められていたが、現在は適応外

ニコチン

- 薬理作用

- アセチルコリン受容体を介して、ドーパミン作動性神経系を刺激
- 摂取方法により作用が異なる
- 浅く頻回に吸煙⇒中枢神経興奮薬として作用
- ゆっくりと深く吸煙した場合⇒中枢神経抑制薬として作用

- 健康被害

- 呼吸機能、発がん性、心血管系への健康被害

13. 重複障害と自己治療仮説

- 重複障害

- 物質依存症患者には他の精神疾患を併存する者が多い(併存率3～7割)
- 精神疾患が引き起こす心理的苦痛への対処に適した精神作用物質を選択する傾向がある

- 物質選択と自己治療仮説

- 「物質依存の本質は快感ではなく、苦痛にあり、物質摂取を促進するのは、物質使用による快感ではなく、苦痛緩和による」(カンツィアン Khantzian EJ)
- 物質依存症患者は、それぞれが抱える苦痛にマッチした薬理作用を持つ物質を選択している
 - 激しい怒り⇒ヘロイン(オピオイド)、大量のアルコール
 - 気分の落ち込み、意欲低下、ADHD症状、解離⇒中枢神経興奮薬(覚醒剤、コカイン)
 - 対人緊張・不安⇒睡眠薬、少量～中等量のアルコール

近年の依存症に関する動き

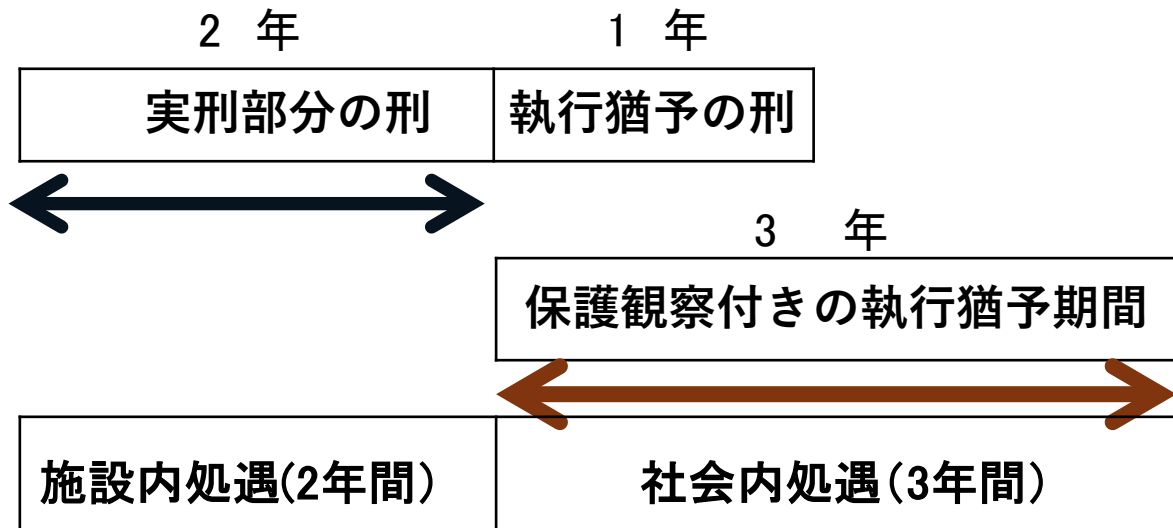
○薬物依存症

- ・平成28年6月1日 「刑法等の一部改正に関する法律」及び「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」施行
 - * 施設内処遇に加え、社会内において更生を促す社会内処遇を実施
- ・平成28年12月 「再犯の防止等の推進に関する法律」施行
 - * 保健医療サービス及び福祉サービスの提供等を規定
- ・平成29年12月 「再犯防止推進計画」閣議決定
 - * 治療・支援機関の整備、民間団体活動支援等
- ・平成30年8月3日取りまとめ 「第五次薬物乱用防止五か年戦略」決定
 - * 適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止

(参考) 刑の一部執行猶予制度

- 刑期の一部機関の執行を猶予する制度
- 執行猶予期間を保護観察付きとすることで、長くかかわることが可能になる

「懲役3年、うち1年を3年間保護観察付きの執行猶予」の場合



関連法規と医師の役割

- ・アルコール健康障害対策基本法、ギャンブル等依存症対策基本法による支援体制の整備。
- ・刑の一部執行猶予制度：社会内処遇（保護観察）を通じた回復支援へのシフト。
- ・医師の役割は「罰する」ことではなく、「より長く治療関係を維持し、支援につなぎ続けること」。

Take-home Messages



脳の病気

依存症は意志の弱さではなく、脳の報酬系の障害

。



包括的アプローチ

薬物・心理・社会・家族の4本柱が必要。



慢性疾患モデル

再発を前提とした長期的な支援が重要。



地域連携

医療機関だけでなく、自助グループや福祉との連携が不可欠

。



回復は可能

適切な治療と支援により、回復は可能。

。

ご清聴ありがとうございました